

139★★★ ✓✓✓	抗酸菌の喀痰培養が陽性の場合、 拡散同定検査 (DNA-DNA hybridization: DDH 法) や抗原精密測定によって結核菌群かどうかを判定する。
140★★★ ✓✓✓	ツベルクリン反応 や インターフェロンγ遊離試験 が陽性の場合でも確定診断と判定できる。
141★★★ ✓✓✓	初回標準治療はリファンピシン・イソニアジド・ピラジナミドにエクトブトールもしくはストレプトマイシンを組み合わせた多剤併用療法で開始する。
142★★★ ✓✓✓	治療期間は条件によらず6ヶ月間が推奨される。
143★★★ ✓✓✓	治療効果の判断のため、2ヶ月に1回は喀痰検査を行う。
144★★★ ✓✓✓	イソニアジドとリファンピシンの両方に耐性の結核は超多剤耐性結核と呼ばれる。
145★★★ ✓✓✓	イソニアジドとリファンピシンのいずれかに耐性（もしくは副作用で使用できない場合）の結核治療は結核専門施設への相談が望ましい。

非結核性抗酸菌症 146 ~ 155

146★★★ ✓✓✓	本邦で最も多い肺非結核性抗酸菌症は <i>M. kansasii</i> によるものである。
147★★★ ✓✓✓	5 類感染症である。
148★★★ ✓✓✓	確定診断のためには2回の気管支洗浄液の培養陽性が必要である。
149★★★ ✓✓✓	血清抗 GPL-core IgA 抗体 (MAC 抗体) は肺 MAC 症の補助診断として有用である。

